

Ibuprofeno: Informacion Farmacologica

Documento educativo para el proyecto MedAssistant - dev/talles

Este documento fue creado exclusivamente con fines educativos para demostrar la funcionalidad de RAG en el curso de Spring AI. No constituye asesoramiento medico profesional.

1. Descripcion General

El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) ampliamente utilizado para el tratamiento del dolor leve a moderado, la fiebre y la inflamacion. Pertenecce al grupo de los derivados del acido propionico y actua inhibiendo las enzimas ciclooxigenasa 1 (COX-1) y ciclooxigenasa 2 (COX-2), lo que reduce la produccion de prostaglandinas responsables del dolor, la inflamacion y la fiebre.

2. Indicaciones

Las indicaciones principales del ibuprofeno incluyen: dolor de cabeza y cefalea tensional, dolor dental, dolor menstrual (dismenorrea), dolor muscular y articular, artritis reumatoide, osteoartritis, fiebre de diversas etiologias, y dolor postoperatorio leve a moderado. Tambien se utiliza en el tratamiento de la inflamacion asociada a lesiones deportivas y traumatismos menores.

3. Dosis Recomendadas

La dosis habitual en adultos es de 200 mg a 400 mg cada 4 a 6 horas segun necesidad. La dosis maxima sin supervision medica es de 1200 mg en 24 horas. Bajo supervision medica, la dosis puede aumentarse hasta 3200 mg diarios en casos de artritis reumatoide u otras condiciones cronicas. Se recomienda tomar el medicamento con alimentos o leche para reducir la irritacion gastrica. En ninios, la dosis se calcula segun el peso corporal, generalmente entre 5 y 10 mg por kilogramo cada 6 a 8 horas.

4. Contraindicaciones

El ibuprofeno esta contraindicado en las siguientes situaciones: pacientes con alergia conocida al ibuprofeno o a otros AINEs; pacientes con ulcera gastrica o duodenal activa o antecedentes de sangrado gastrointestinal; insuficiencia renal severa; insuficiencia hepatica severa; tercer trimestre del embarazo; pacientes con insuficiencia cardiaca severa; y pacientes que han experimentado reacciones de hipersensibilidad como asma, rinitis o urticaria tras la administracion de aspirina u otros AINEs.

5. Interacciones Medicamentosas

El ibuprofeno presenta interacciones relevantes con varios grupos de medicamentos. Puede reducir el efecto antihipertensivo de los inhibidores de la ECA, los bloqueadores de los receptores de angiotensina (ARA II) y los diuréticos. El uso combinado con anticoagulantes como warfarina aumenta el riesgo de sangrado. No se recomienda el uso simultáneo con otros AINEs, incluida la aspirina en dosis antiinflamatorias, ya que aumenta el riesgo de efectos adversos gastrointestinales.

También puede aumentar los niveles plasmáticos de litio y metotrexato, incrementando el riesgo de toxicidad de estos fármacos. En pacientes que toman corticosteroides, el uso concomitante de ibuprofeno aumenta el riesgo de ulceración gastrointestinal. Se debe tener precaución en pacientes que toman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), ya que la combinación puede aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal.

6. Efectos Adversos

Los efectos adversos frecuentes incluyen náuseas, dolor abdominal, dispepsia, diarrea y flatulencia. Los efectos menos frecuentes incluyen mareos, cefalea, somnolencia y retención de líquidos. Los efectos raros pero potencialmente graves incluyen sangrado gastrointestinal, perforación gástrica, reacciones alérgicas severas (anafilaxia), insuficiencia renal aguda, hepatotoxicidad y eventos cardiovasculares como infarto de miocardio, especialmente con uso prolongado a dosis altas.

En pacientes con hipertensión arterial, el ibuprofeno puede elevar la presión arterial entre 3 y 6 mmHg y reducir la eficacia de los medicamentos antihipertensivos. Se recomienda monitoreo frecuente de la presión arterial en pacientes hipertensos que requieran tratamiento con ibuprofeno.

7. Precauciones en Poblaciones Especiales

En adultos mayores, el ibuprofeno debe usarse con precaución debido al mayor riesgo de efectos adversos gastrointestinales, renales y cardiovasculares. Se recomienda utilizar la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible. En pacientes con antecedentes de enfermedad gastrointestinal, se puede considerar la coadministración de un inhibidor de la bomba de protones para reducir el riesgo de ulceración.

Durante el embarazo, el ibuprofeno está contraindicado en el tercer trimestre por el riesgo de cierre prematuro del conducto arterioso fetal y oligohidramnios. En los dos primeros trimestres, solo debe usarse si el beneficio justifica el riesgo potencial. Durante la lactancia, el ibuprofeno se considera generalmente seguro ya que se excreta en cantidades mínimas en la leche materna.